

CEVORA



OS SCRIPTS DA CEVORA



Manual operacional para conduzir pacientes
da primeira mensagem à consulta de avaliação.

Antes de abrir o WhatsApp

Este material organiza o atendimento comercial e administrativo. Ele não substitui avaliação médica, prontuário, orientação clínica, consentimento informado nem as regras profissionais aplicáveis à sua operação.

Use para

- acolher e orientar pessoas interessadas;
- apresentar com clareza a consulta de avaliação;
- padronizar follow-up, confirmação e reativação;
- registrar gargalos e treinar a equipe.

Nunca use para

- diagnosticar por mensagem;
- garantir resultado ou indicação;
- pressionar uma decisão cirúrgica;
- inventar prova, depoimento ou urgência;
- coletar informações sensíveis sem necessidade.

Regra-mestra: o script deve reduzir incerteza e facilitar o próximo passo. Se ele esconde informação, exagera, constrange ou substitui critério médico, não pertence a este livro.

Texto original e síntese metodológica desenvolvidos para a Cevora. Referências de estudo listadas ao final. Edição 1.0 – julho de 2026.

Eu encontrei o vazamento depois do clique.

Minha mãe é dentista. Eu cresci vendo de perto uma contradição que, por muito tempo, eu não sabia nomear: uma profissional podia estudar durante anos, atender bem, cuidar de cada detalhe e ainda ter dificuldade para transformar toda essa competência em novos pacientes.

Quando comecei a ajudá-la, pensei que o problema fosse simples. Mais anúncios. Mais conteúdo. Mais gente chegando.

Então eu olhei para as conversas.

A pessoa demonstrava interesse, mandava uma mensagem e desaparecia entre uma resposta genérica, uma pergunta de preço tratada como tabela, um follow-up esquecido ou um agendamento que terminava em silêncio.

A clínica não estava perdendo apenas leads. Estava perdendo a chance de ser compreendida antes mesmo de o atendimento médico começar.

Foi assim que nasceu a Cevora. Não para ensinar cirurgia a cirurgiões. Meu trabalho começa onde o atendimento médico ainda não começou: no caminho entre o interesse, a confiança e a avaliação.

Este livro é o mapa desse caminho.

Otávio

Fundador da Cevora - O Filho da Clínica

Não leia como um livro. Implemente como um sistema.

01

Escolha o gargalo

Preço, demora, follow-up, no-show, reativação ou pós-avaliação. Comece onde a perda está mais visível.

02

Adapte os campos

Substitua os colchetes, ajuste o tom e remova qualquer trecho que não represente a operação real da clínica.

03

Meça a mudança

Compare conversas, agendamentos, comparecimentos e motivos de perda antes e depois.

Legenda de operação

ROTEIRO

mensagem pronta para adaptar;

ROTA

o que fazer conforme a resposta;

REGISTRAR

dado mínimo para não depender da memória;

NOTA DO OPERADOR

o mecanismo por trás da mensagem;

NÃO FAÇA ISSO

atalho que parece eficiente, mas cria vazamento;

CRENÇA

o que a pessoa precisa compreender para avançar.

Três modos de consulta

Durante o atendimento: use o índice rápido no fim do livro.

No treinamento: estude um módulo por encontro e simule as rotas.

Na gestão: audite cinco conversas por atendente a cada semana.

O caminho inteiro, sem atalhos de papel machê.

PARTE I	A máquina antes da mensagem	6
01.	Fundamentos da condução	7
02.	Jornada, etapas e crenças	10
PARTE II	Da primeira mensagem ao agendamento	13
03.	Primeiro contato	14
04.	Qualificação sem interrogatório	18
05.	Apresentação do cirurgião	21
06.	Adaptação por procedimento	24
07.	Pergunta de preço	28
08.	Consulta de avaliação	32
09.	Agendamento	36
PARTE III	O que acontece depois do interesse	39
10.	Cadência de follow-up	40
11.	Confirmação e comparecimento	43
12.	Cancelamento, atraso e no-show	46
13.	Tratamento de objeções	49
14.	Reativação	54
15.	Pós-avaliação e decisão	57
PARTE IV	Gestão, treinamento e escala	61
16.	Medição e melhoria	62
APÊNDICES	Biblioteca, checklists e implantação	66

PARTE I

A máquina antes da mensagem

Antes de trocar palavras, organize o processo que
decide o que acontece com cada conversa.

CEVORA

Fundamentos da condução

Uma boa mensagem chama a atenção, mostra uma vantagem, sustenta a confiança, faz sentido e pede um próximo passo claro.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Esta clínica entende o que eu busco e sabe me conduzir sem me pressionar.

Responder não é conduzir. Uma resposta pode ser educada, rápida e completamente inútil. Condução significa saber qual incerteza precisa ser reduzida agora e qual próximo passo faz sentido depois.

NOTA DO OPERADOR

A cirurgia plástica pode despertar desejo por si só. A confiança no cirurgião, na segurança do processo e na qualidade da experiência, não. O atendimento existe para distribuir confiança, não para fabricar entusiasmo.

A RÉGUA

Os cinco testes de toda mensagem

Teste	Pergunta operacional	Sinal de falha
1. Atenção	A primeira linha parece escrita para esta pessoa?	Saudação genérica ou bloco enorme.
2. Vantagem	Ela entende o que ganha ao responder ou avançar?	A mensagem fala apenas da clínica.
3. Prova	Existe base real para o que afirmamos?	Adjetivos sem evidência ou promessa inventada.
4. Compreensão	A lógica é simples e plausível?	Jargão, excesso de detalhes ou salto de raciocínio.

Teste	Pergunta operacional	Sinal de falha
5. Ação	O próximo passo está evidente e é fácil de executar?	"Qualquer coisa estamos à disposição".

PRINCÍPIO

Toda mensagem deve fazer apenas um trabalho principal. Acolher, compreender, explicar, agendar, confirmar ou recuperar. Quando uma mensagem tenta fazer tudo, vira um panfleto dobrado dentro do WhatsApp.

A anatomia de uma resposta que conduz

Bloco	Função	Exemplo
Reconhecimento	Mostrar que a mensagem foi lida.	"Entendi que sua principal dúvida é sobre [procedimento]."
Contexto	Explicar por que uma informação importa.	"Como cada planejamento depende da avaliação, o valor pode variar."
Próximo passo	Reduzir o esforço de decisão.	"Posso verificar terça às 15h ou quinta às 10h."

NÃO FAÇA ISSO

Não copie um script para esconder falta de atenção. Personalização não é colocar o primeiro nome no início. É responder ao que a pessoa realmente disse.

Padrão de linguagem da equipe

- **Humana:** frases naturais, sem excesso de formalidade.
- **Clara:** uma ideia por parágrafo.
- **Segura:** não promete indicação, resultado ou prazo clínico.
- **Direcional:** termina com pergunta ou escolha útil.
- **Rastreável:** deixa evidente a etapa e a próxima ação.

CHECKLIST DE ENVIO

- ☐ Li a mensagem inteira antes de responder.
- ☐ Usei uma informação específica da conversa.
- ☐ Não dei orientação médica nem prometi resultado.
- ☐ Expliquei apenas o necessário para esta etapa.
- ☐ Terminei com um próximo passo claro.

Jornada, etapas e crenças

O script muda quando a etapa muda. Sem um mapa, a equipe envia a mensagem certa na hora errada.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Existe um próximo passo seguro, claro e adequado para mim.

Uma conversa não é uma linha reta. É uma sequência de pequenos compromissos. Primeiro a pessoa responde. Depois explica o que busca. Em seguida, compreende o papel da avaliação. Só então escolhe um horário.

Pipeline mínimo da clínica

Etapa	Objetivo	Saída da etapa	Prazo
Novo interesse	Reconhecer e iniciar.	Primeira resposta enviada.	Assim que possível.
Contexto compreendido	Entender procedimento e dúvida principal.	Necessidade administrativa clara.	Na mesma conversa.
Avaliação apresentada	Explicar valor do próximo passo.	Aceitou ver disponibilidade.	Na mesma conversa.
Agendamento	Definir data, horário e condições.	Compromisso registrado.	Imediato.
Confirmação	Reduzir esquecimento e incerteza.	Presença confirmada.	Conforme política.
Pós-avaliação	Acompanhar dúvidas e decisão.	Próxima ação definida.	Conforme orientação.
Reativação	Retomar sem perseguir.	Resposta, pausa ou encerramento.	Por cadência.

A crença central do atendimento

FÓRMULA DE CLAREZA

Uma avaliação individual é a forma mais segura de transformar meu interesse em um planejamento real, e esta clínica consegue me conduzir até ela com clareza.

Essa frase não deve ser enviada ao paciente. Ela é a estrela do norte da equipe. Se uma mensagem contradiz essa ideia, ela provavelmente está empurrando, confundindo ou reduzindo o atendimento a preço.

As dez perguntas de auditoria

Pergunta	Aplicação no atendimento
1. O que há de diferente?	Qual detalhe da pessoa, do procedimento ou da clínica torna a resposta específica?
2. O que isso muda para ela?	Qual incerteza será reduzida ao avançar?
3. Como ela sabe que é real?	Que informação verificável e autorizada sustenta a mensagem?
4. O que a impede?	Preço, medo, tempo, distância, parceiro, experiência anterior?
5. O que criou o problema?	Falta de informação, expectativa irreal, atendimento anterior, momento pessoal?
6. Por que agir agora?	Existe um motivo real para definir o próximo passo, sem falsa urgência?
7. Por que confiar?	Clareza, postura, credenciais autorizadas, processo e transparência.
8. Como funciona?	A pessoa sabe o que acontece na avaliação e depois dela?
9. Como começar?	O primeiro passo exige pouco esforço?
10. O que ela arrisca?	O que acontece se continuar sem informação ou adiar indefinidamente?

PRINCÍPIO

O próximo passo deve ser proporcional à confiança atual. Uma pessoa que acabou de chegar pode aceitar responder uma pergunta. Ainda não aceitou uma cirurgia, uma ligação longa nem um interrogatório.

Microcompromissos

1. **Responder:** confirmar o procedimento ou a principal dúvida.
2. **Explicar:** compartilhar contexto suficiente para a equipe orientar.

3. **Compreender:** entender por que a avaliação é necessária.
4. **Escolher:** selecionar entre duas opções de horário.
5. **Confirmar:** validar dados e compromisso.

NÃO FAÇA ISSO

Nunca avance a etapa no sistema só porque uma mensagem foi enviada. A etapa muda quando houve um comportamento observável: respondeu, aceitou, escolheu, confirmou ou compareceu.

PARTE II

Da primeira mensagem ao agendamento

A pessoa não precisa de um texto bonito. Precisa sentir
que foi compreendida e saber o que fazer depois.

CEVORA

Primeiro contato

A primeira resposta deve parecer o início de uma conversa, não a abertura automática de um chamado.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Minha mensagem chegou a uma equipe atenta e preparada.

A primeira linha carrega um peso desproporcional. Se ela parece automática, a pessoa assume que o restante também será. O objetivo não é impressionar. É reduzir a barreira para a próxima resposta.

ROTEIRO Quando a pessoa informa o procedimento

Situação: Mensagem direta pelo WhatsApp ou Instagram.

Objetivo: Acolher, confirmar o interesse e descobrir a principal dúvida.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Que bom receber sua mensagem. Vi que você quer saber mais sobre [procedimento].

Você quer começar entendendo como funciona a avaliação, vendo os horários disponíveis ou esclarecendo outra dúvida específica?

Rotas:

- Se perguntar preço, use o Módulo 7.
- Se falar de medo ou segurança, acolha e conduza para a avaliação.
- Se pedir horário, avance para o Módulo 9.

Registrar: origem, procedimento de interesse e dúvida principal.

Evite: enviar imediatamente um texto longo sobre o cirurgião.

VERSÃO OBJETIVA

Olá, [Nome]. Recebi seu contato sobre [procedimento]. Para eu te orientar de forma objetiva, qual é sua principal dúvida neste momento?

VERSÃO ACOLHEDORA

Oi, [Nome]. Obrigada por chamar a gente. Vi que seu interesse é em [procedimento]. Me conta: o que você mais quer entender antes de pensar no próximo passo?

ROTEIRO Quando a pessoa manda apenas "oi"

Situação: Contato sem contexto.

Objetivo: Abrir uma escolha simples sem soar robótico.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Seja bem-vinda(o). Eu sou [Atendente], da equipe do Dr.(a) [Cirurgião].

Você quer informações sobre algum procedimento específico ou sobre a consulta de avaliação?

Registrar: canal e horário do primeiro contato.

Evite: "Como posso ajudar?" isolado, sem nenhum contexto.

ROTEIRO Lead vindo de anúncio

Situação: A pessoa clicou em um anúncio de um procedimento específico.

Objetivo: Conectar o anúncio à conversa e evitar que ela repita tudo.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Vi que você chegou pelo nosso conteúdo sobre [procedimento]. Para não te mandar uma resposta genérica, me conte: o que chamou sua atenção ou qual dúvida você quer resolver primeiro?

Rotas:

- Se responder com um objetivo estético, reconheça sem julgar.
- Se responder "preço", vá ao Módulo 7.
- Se não responder, entre na cadência do Módulo 10.

Registrar: campanha ou conteúdo de origem.

ROTEIRO Contato por indicação

Situação: A pessoa menciona um paciente, médico ou conhecido.

Objetivo: Reconhecer a indicação sem presumir intimidade.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Que bom receber seu contato por indicação de [Pessoa/Fonte]. Obrigada pela confiança.

Você já sabe qual procedimento gostaria de conhecer melhor ou prefere que eu explique primeiro como funciona a consulta?

Evite: usar o nome do indicador como pressão para agendar.

ROTEIRO Mensagem fora do horário

Situação: Contato recebido quando a equipe não está disponível.

Objetivo: Confirmar recebimento e alinhar expectativa real.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Sua mensagem chegou para a equipe da clínica. Nosso atendimento funciona de [horário].

Assim que retornarmos, vamos ler sua mensagem e te orientar por aqui. Se quiser adiantar, pode me dizer qual procedimento despertou seu interesse.

Registrar: horário de entrada e horário da resposta humana.

Evite: prometer resposta imediata quando não há equipe.

NOTA DO OPERADOR

Rapidez importa, mas velocidade sem direção apenas entrega uma resposta ruim mais cedo. O indicador correto combina tempo de primeira resposta com taxa de continuidade da conversa.

PRIMEIRO CONTATO

☐ A mensagem cita o procedimento, origem ou detalhe real.

☐ A primeira pergunta é fácil de responder.

☐ Não há mais de uma pergunta principal.

☐ A pessoa sabe com quem está falando.

☐ A conversa termina aberta para o próximo passo.

Qualificação sem interrogatório

Entender contexto não exige transformar o WhatsApp em formulário de alfândega.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Posso explicar o que busco sem ser julgada(o) ou pressionada(o).

Qualificar é descobrir o suficiente para orientar a próxima etapa. Não é coletar toda a história clínica, decidir indicação ou satisfazer curiosidade administrativa.

PRINCÍPIO

Uma pergunta por vez. A resposta da pessoa decide a próxima pergunta.

O mínimo que a equipe precisa saber

Informação	Por que importa	Como perguntar
Procedimento ou região	Direciona a conversa.	"Qual procedimento você gostaria de entender melhor?"
Dúvida principal	Mostra o gargalo atual.	"O que você precisa esclarecer antes de avançar?"
Cidade	Ajuda com logística.	"Você é de [Cidade] ou viria de outra região?"
Momento aproximado	Orienta disponibilidade sem pressionar.	"Você pensa nisso para algum período específico ou ainda está pesquisando?"
Experiência prévia	Evita repetir informação.	"Você já passou por alguma avaliação antes?"

ROTEIRO Qualificação leve

Situação: A pessoa respondeu qual procedimento deseja.

Objetivo: Descobrir a dúvida principal.

MENSAGEM

Entendi. Sobre [procedimento], o que pesa mais para você hoje: entender se existe indicação, saber como é a avaliação ou organizar valores e datas?

Rotas:

- Se escolher indicação, explique que isso depende da avaliação médica.
- Se escolher avaliação, use Módulo 8.
- Se escolher valores, use Módulo 7.

ROTEIRO Momento da decisão

Situação: A pessoa demonstra interesse, mas sem horizonte.

Objetivo: Entender a maturidade da decisão sem criar urgência falsa.

MENSAGEM

Perfeito. Você está pensando em realizar isso em algum período específico ou, por enquanto, quer apenas entender as possibilidades com calma?

Registrar: momento: agora, 1-3 meses, 3-6 meses, sem previsão.

Evite: "Quando você quer operar?" antes de qualquer contexto.

ROTEIRO Pessoa de outra cidade

Situação: A logística pode ser uma barreira.

Objetivo: Reconhecer a distância e explicar apenas o processo administrativo.

MENSAGEM

Entendi, você viria de [Cidade]. A equipe pode te explicar como organizamos a avaliação e a agenda para pacientes de fora. Para eu orientar corretamente, você gostaria primeiro de saber sobre datas ou sobre as etapas do atendimento?

Evite: prometer que tudo pode ser resolvido a distância sem confirmação médica.

NÃO FAÇA ISSO

Não pergunte peso, doenças, medicamentos, fotos ou histórico clínico por rotina comercial. Informação de saúde deve ser solicitada apenas quando necessária, pelo canal e profissional adequados.

A técnica da escada

Degrau	Exemplo
1. Pergunta simples	"Qual procedimento despertou seu interesse?"
2. Validação	"Entendi. Essa é uma dúvida comum antes da avaliação."
3. Pergunta de contexto	"Você já passou por alguma consulta sobre isso?"
4. Explicação	"A avaliação existe para analisar seu caso individualmente."
5. Escolha	"Quer que eu explique a avaliação ou veja horários?"

NOTA DO OPERADOR

A pessoa quase sempre revela mais quando percebe que cada pergunta tem uma razão. Perguntas desconectadas parecem coleta de dados. Perguntas encadeadas parecem cuidado.

Apresentação do cirurgião

Autoridade não é uma parede de títulos. É a combinação entre competência verificável, processo claro e postura.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Estou considerando um profissional que leva meu caso e minha segurança a sério.

A apresentação precisa responder ao que a pessoa quer saber, não recitar o currículo completo. Use apenas credenciais verdadeiras, atuais, autorizadas e relevantes.

Blocos de autoridade

Bloco	Conteúdo permitido	Uso
Identidade	Nome e área de atuação.	Toda apresentação.
Credenciais	Formação e títulos verificáveis.	Quando relevantes e autorizados.
Foco	Procedimentos e perfil de atendimento.	Conectar ao interesse.
Processo	Como a avaliação é conduzida.	Reduzir incerteza.
Prova	Depoimentos e resultados com consentimento.	Somente se reais e adequados.

ROTEIRO Apresentação curta

Situação: A pessoa pergunta quem é o profissional.

Objetivo: Dar contexto suficiente e retornar para a necessidade dela.

MENSAGEM

O Dr.(a) [Nome] atua em [área/foco verificável] e conduz cada indicação a partir de uma avaliação individual.

Como você tem interesse em [procedimento], na consulta ele(a) vai entender seu objetivo, avaliar possibilidades e explicar o que faz ou não sentido para o seu caso.

Rotas:

- Depois, pergunte se deseja entender a avaliação ou ver horários.

Evite: "É o melhor da cidade" ou qualquer superlativo sem prova.

ROTEIRO Apresentação por áudio de 30 segundos

Situação: A pessoa prefere um áudio ou a conversa pede mais calor humano.

Objetivo: Humanizar sem virar monólogo.

MENSAGEM

Roteiro de fala: "Oi, [Nome]. Só para te contextualizar rapidamente: o Dr.(a) [Nome] trabalha com [foco] e a consulta não é tratada como um orçamento padrão. Ele(a) primeiro entende o que você busca, avalia seu caso e explica possibilidades, limites e próximos passos. Se quiser, eu posso te mostrar como funciona a agenda."

Evite: enviar um áudio de mais de 60 segundos sem que a pessoa peça.

ROTEIRO Quando pedem fotos de antes e depois

Situação: A pessoa busca prova visual.

Objetivo: Direcionar para canais autorizados sem prometer equivalência.

MENSAGEM

Temos alguns resultados publicados nos canais oficiais da clínica, sempre com autorização. Posso te enviar o link correspondente a [procedimento].

Só é importante lembrar que cada caso tem anatomia, indicação e evolução próprias; a avaliação é o que permite conversar sobre possibilidades reais para você.

Evite: usar um resultado alheio como promessa do resultado da pessoa.

PRINCÍPIO

Prova boa reduz dúvida. Prova ruim cria expectativa que a avaliação precisará desfazer depois.

Mini-VSL: vídeo de apresentação da avaliação

Bloco	Duração	Conteúdo
Gancho	5-10s	"Se você chegou até aqui querendo entender [procedimento], a primeira coisa importante é saber que nenhum planejamento responsável começa por uma tabela."
Problema	10-15s	Explicar que fotos e preços soltos não consideram o caso individual.
Solução	15-20s	Apresentar a avaliação como encontro para entender objetivo, indicação, limites e planejamento.
Confiança	10-15s	Mostrar ambiente, equipe ou credencial real, sem exagero.
Ação	5-10s	"Fale com a equipe e veja os próximos horários disponíveis."

Adaptação por procedimento

A estrutura permanece. O medo, a expectativa e a linguagem mudam.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

A equipe entende as particularidades do que estou buscando sem fingir que meu caso já foi avaliado.

Personalizar não significa inventar orientação clínica. Significa reconhecer que uma pessoa interessada em rinoplastia chega com dúvidas diferentes de alguém que considera cirurgia mamária ou contorno corporal.

Mapa de sensibilidades

Grupo	Dúvidas frequentes	Tom recomendado
Nariz e face	Naturalidade, identidade, respiração, exposição social.	Preciso, sereno e individualizado.
Mamas	Proporção, cicatriz, recuperação, maternidade.	Acolhedor, sem pressupor motivação.
Contorno corporal	Resultado, cicatriz, rotina, combinação de procedimentos.	Realista e organizado.
Reparadora	Função, história pessoal, cobertura e etapas.	Respeitoso, sem explorar vulnerabilidade.
Masculino	Discrição, tempo de afastamento, naturalidade.	Objetivo e sem estereótipos.

ROTEIRO Rinoplastia

Situação: Interesse em mudar o nariz.

Objetivo: Reconhecer busca por harmonia sem prometer formato.

MENSAGEM

Entendi seu interesse em rinoplastia, [Nome]. Como cada nariz precisa ser analisado em relação ao rosto, a avaliação é o momento de conversar sobre o que te incomoda e o que pode ser considerado com segurança e naturalidade.

Você quer entender primeiro como funciona essa consulta ou prefere que eu veja horários?

Evite: prometer "nariz perfeito", copiar referência ou afirmar resultado por foto.

ROTEIRO Cirurgia mamária

Situação: Interesse em prótese, mastopexia ou redução.

Objetivo: Abrir espaço para o objetivo sem presumir a técnica.

MENSAGEM

Entendi, [Nome]. Em cirurgia mamária, o mesmo desejo pode envolver planejamentos bem diferentes. Por isso, antes de falar em técnica ou tamanho, o Dr.(a) [Nome] precisa entender seu objetivo e avaliar seu caso.

O que você quer esclarecer primeiro: como funciona a avaliação, informações gerais sobre recuperação ou disponibilidade de horários?

Evite: definir tamanho, técnica ou indicação por mensagem.

ROTEIRO Lipoaspiração e contorno corporal

Situação: Interesse em lipo, abdominoplastia ou combinação.

Objetivo: Diferenciar desejo de planejamento clínico.

MENSAGEM

Vi que seu interesse é em contorno corporal. A equipe pode te orientar sobre o processo, mas a definição do que realmente faz sentido depende da avaliação do Dr.(a) [Nome], porque objetivos parecidos podem exigir abordagens diferentes.

Você já passou por alguma avaliação ou esta seria a primeira?

Evite: usar "seca", "transforma" ou linguagem que prometa mudança corporal garantida.

ROTEIRO Cirurgia facial

Situação: Interesse em pálpebras, face ou pescoço.

Objetivo: Preservar naturalidade e expectativa realista.

MENSAGEM

Entendi. Em procedimentos faciais, a conversa costuma ser muito individual porque pequenas diferenças mudam o planejamento. Na avaliação, o Dr.(a) [Nome] consegue entender o que você percebe e explicar possibilidades sem descaracterizar sua expressão.

Posso te explicar como funciona a consulta ou verificar os próximos horários.

Evite: linguagem de rejuvenescimento garantido ou promessa de idade aparente.

ROTEIRO Cirurgia reparadora

Situação: A pessoa relata história sensível ou necessidade funcional.

Objetivo: Acolher sem transformar a dor em argumento comercial.

MENSAGEM

Obrigada por compartilhar isso, [Nome]. Imagino que seja uma questão importante para você.

A equipe pode organizar a avaliação para que o Dr.(a) [Nome] compreenda seu caso e explique o que pode ser analisado. Você prefere que eu detalhe como funciona a consulta ou veja disponibilidade?

Evite: explorar emocionalmente a história, prometer cobertura ou indicação.

NOTA DO OPERADOR

O script bom reconhece a categoria do desejo. O médico reconhece a indicação. Misturar esses papéis é um atalho perigoso.

Pergunta de preço

O problema não é falar de dinheiro. É tratar uma decisão individual como item de prateleira.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Vou receber transparência sem que meu caso seja reduzido a um número solto.

Preço é uma pergunta legítima. Desviar, esconder ou repreender a pessoa destrói confiança. Ao mesmo tempo, enviar apenas um número pode transformar o cirurgião em uma comparação rasa antes de qualquer contexto.

PRINCÍPIO

Responda o que pode ser respondido. Explique honestamente o que depende da avaliação. Depois conduza.

ROTEIRO Quando não existe valor cirúrgico sem avaliação

Situação: A pessoa pergunta "quanto custa?".

Objetivo: Ser transparente sobre o processo e apresentar o próximo passo.

MENSAGEM

Entendo, [Nome]. É importante organizar o investimento antes de decidir.

Como o valor depende do planejamento individual, da estrutura necessária e do que for indicado na avaliação, a equipe não consegue informar um valor total com responsabilidade antes da consulta.

Posso te explicar o valor da avaliação e os próximos horários?

Evite: "Só damos valor na consulta" sem nenhuma explicação.

ROTEIRO Quando existe uma faixa real autorizada

Situação: A clínica possui faixa inicial que pode ser divulgada.

Objetivo: Dar referência sem criar orçamento falso.

MENSAGEM

Para te dar uma referência real, casos de [procedimento] costumam partir de [faixa autorizada], mas isso não funciona como orçamento porque o planejamento varia bastante.

O valor individual é definido somente depois da avaliação. Quer que eu te explique como ela funciona ou veja os horários?

Registrar: faixa enviada e versão vigente da tabela.

Evite: usar "a partir de" se quase nenhum caso se aproxima desse valor.

ROTEIRO Valor da consulta de avaliação

Situação: A pessoa pergunta quanto custa a consulta.

Objetivo: Apresentar o valor, o que está incluído e a forma de agendamento.

MENSAGEM

O investimento na consulta de avaliação é de [valor]. Nela, o Dr.(a) [Nome] entende seu objetivo, realiza a avaliação necessária e explica possibilidades, limites e planejamento.

Temos [dia/hora A] ou [dia/hora B]. Qual funciona melhor para você?

Registrar: valor informado, política de reserva e resposta.

ROTEIRO Quando a pessoa insiste em saber o total

Situação: Ela não quer agendar sem uma estimativa.

Objetivo: Respeitar o critério de decisão e manter honestidade.

MENSAGEM

Eu entendo que você queira essa informação antes de reservar a consulta. O que eu não quero é te passar um número que pareça definitivo sem que o Dr.(a) [Nome] tenha avaliado o que realmente seria indicado.

Posso te informar [o que a clínica pode informar: faixa, valor da consulta, formas gerais de pagamento] e você decide com calma se faz sentido avançar.

Evite: criar confronto ou insinuar que quem pergunta preço não valoriza qualidade.

ROTEIRO "Outra clínica cobra menos"

Situação: Comparação direta de preço.

Objetivo: Não atacar concorrentes e ampliar critérios de comparação.

MENSAGEM

Faz sentido comparar antes de decidir, [Nome]. Valores podem variar porque o planejamento, a equipe, a estrutura e as particularidades de cada caso são diferentes.

O mais seguro é comparar também como cada profissional avalia, explica limites e organiza o acompanhamento. Se quiser, eu posso te mostrar exatamente como funciona nossa avaliação para você decidir com mais informação.

Evite: desqualificar outro profissional ou usar medo.

O modelo de resposta em quatro movimentos

Movimento	Função	Exemplo curto
1. Validar	Mostrar que a pergunta é legítima.	"Entendo que o investimento importa."
2. Responder	Entregar o que é possível.	"A avaliação custa [valor]."
3. Contextualizar	Explicar variação sem esconder.	"O total depende do planejamento individual."
4. Conduzir	Oferecer próximo passo.	"Prefere terça ou quinta?"

NÃO FAÇA ISSO

Nunca use vergonha como ferramenta: "quem busca qualidade não pergunta preço". Além de agressivo, isso revela que a clínica não sabe explicar valor sem atacar a pergunta.

Consulta de avaliação

A consulta não é um obstáculo entre a pessoa e o preço. É o ponto em que interesse vira entendimento individual.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

A avaliação me dará clareza suficiente para decidir sem improviso.

Quando a equipe apresenta a consulta apenas como etapa burocrática, a pessoa tenta pulá-la. Quando explica o que muda depois dela, a avaliação ganha valor próprio.

O que a apresentação precisa responder

- Por que a avaliação é necessária.
- O que o profissional procura compreender.
- Que tipo de resposta a pessoa pode esperar.
- Quanto custa, quando aplicável.
- Quanto tempo deve reservar para a consulta, se essa informação puder ser divulgada.
- O que precisa levar ou preparar.
- Qual é o próximo passo depois da consulta.

ROTEIRO Apresentação completa da avaliação

Situação: A pessoa ainda não entendeu o valor da consulta.

Objetivo: Transformar a avaliação em uma etapa concreta e compreensível.

MENSAGEM

A avaliação é o momento em que o Dr.(a) [Nome] entende o que você busca, analisa seu caso individualmente e explica o que pode ou não fazer sentido.

Ela não serve apenas para entregar um valor. Serve para alinhar expectativa, segurança, possibilidades e o planejamento necessário.

O investimento é [valor, se aplicável]. Quer que eu veja os próximos horários?

ROTEIRO Avaliação paga

Situação: A pessoa questiona a cobrança.

Objetivo: Explicar trabalho e entrega sem defensividade.

MENSAGEM

Entendo sua dúvida. A consulta é um atendimento profissional completo, em que o Dr.(a) [Nome] dedica tempo para compreender seu objetivo, avaliar o caso e orientar possibilidades e limites.

Por isso, o investimento é de [valor]. Posso verificar [opção A] ou [opção B] para você.

Evite: justificar com desprezo por consultas gratuitas ou concorrentes.

ROTEIRO Avaliação inicial on-line, quando a clínica oferece

Situação: Pessoa de outra cidade ou com barreira logística.

Objetivo: Explicar claramente o alcance e o limite do formato.

MENSAGEM

A clínica oferece uma etapa inicial on-line para [finalidade real]. Ela ajuda a organizar informações e próximos passos, mas não substitui o que precisa ser feito presencialmente quando houver essa necessidade.

Quer que eu te explique como funciona ou veja os horários disponíveis?

Evite: tratar conversa on-line como indicação definitiva.

ROTEIRO Quando a pessoa quer falar direto com o médico

Situação: Pedido de contato antes de agendar.

Objetivo: Respeitar a necessidade e organizar o acesso correto.

MENSAGEM

Entendo que você queira esclarecer isso diretamente com o Dr.(a) [Nome]. Para que ele(a) consiga te orientar com atenção e responsabilidade, essas dúvidas são tratadas na consulta de avaliação.

Eu posso organizar o melhor horário e te explicar como se preparar para a consulta.

Evite: "O médico não responde WhatsApp" em tom de barreira.

PRINCÍPIO

O valor percebido nasce da especificidade. "Consulta completa" é vago. Explicar o que a pessoa entende, recebe e consegue decidir depois é concreto.

APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO

- ☐ Expliquei por que a avaliação existe.
- ☐ Não reduzi a consulta a orçamento.
- ☐ Informe valor e política quando aplicável.
- ☐ Não prometi indicação nem resultado.
- ☐ Ofereci um próximo passo objetivo.

Agendamento

Interesse sem data é apenas uma conversa simpática arquivada.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

O agendamento será simples, claro e sem surpresas.

O fechamento do agendamento deve reduzir escolhas, confirmar condições e transformar uma intenção vaga em compromisso observável.

ROTEIRO Escolha entre dois horários

Situação: A pessoa aceitou ver disponibilidade.

Objetivo: Reduzir fricção de decisão.

MENSAGEM

Tenho disponibilidade na [opção A] ou [opção B]. Qual funciona melhor para você?

Rotas:

- Se nenhum servir, pergunte período preferido.
- Se escolher, confirme dados antes de encerrar.

Evite: "Que dia você pode?" com agenda completamente aberta.

ROTEIRO Nenhum horário funciona

Situação: A pessoa rejeitou as duas opções.

Objetivo: Descobrir janela sem transformar a conversa em pingue-pongue.

MENSAGEM

Sem problema. Para eu procurar de forma mais certa, funciona melhor para você de manhã, à tarde ou no início da noite? E quais dias costuma conseguir organizar?

Registrar: preferência de dia e turno.

ROTEIRO Confirmação dos dados

Situação: Horário escolhido.

Objetivo: Evitar erros e deixar o compromisso completo.

MENSAGEM

Perfeito, [Nome]. Sua avaliação ficou reservada para [data], às [hora], com o Dr.(a) [Nome], em [local/formato].

O investimento da avaliação é [valor], conforme [política real de pagamento/reserva].
Confirme para mim seu nome completo e [dado administrativo necessário]?

Evite: pedir dados que a clínica não precisa nesta etapa.

ROTEIRO Reserva com sinal, quando aplicável

Situação: A clínica possui política de reserva.

Objetivo: Explicar regra antes do pagamento.

MENSAGEM

Para confirmar esse horário, a clínica solicita [sinal/pagamento] de [valor], conforme nossa política de reserva. Antes de você realizar o pagamento, eu te envio as condições de remarcação e cancelamento para ficar tudo claro.

Posso encaminhar?

Evite: enviar chave de pagamento sem explicar condições.

ROTEIRO Pessoa precisa falar com alguém

Situação: Ela depende do parceiro, da família ou da agenda profissional.

Objetivo: Criar próxima ação real sem pressionar.

MENSAGEM

Claro. Faz sentido alinhar antes. Para não deixar a conversa solta, posso te chamar novamente [dia/período] e verificar se conseguiu organizar?

Registrar: data combinada de retorno.

Evite: "Tudo bem, qualquer coisa chama".

Mensagem de fechamento do agendamento

MODELO

Data: [data e hora]

Profissional: [nome]

Local: [endereço/link]

Investimento: [valor e forma]

Orientações administrativas: [o que levar/antecedência]

Remarcação: [política curta ou link]

NOTA DO OPERADOR

Agendamento bom termina com uma fotografia textual do compromisso. A pessoa não deve precisar procurar cinco mensagens diferentes para descobrir onde, quando e quanto.

PARTE III

O que acontece depois do interesse

A maioria das oportunidades não desaparece de uma vez. Ela esfria em pequenas omissões.

CEVORA

Cadência de follow-up

Follow-up não é repetir a mesma pergunta até a pessoa se render. É criar novos motivos para responder.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Posso retomar esta conversa sem ser perseguida(o).

Um único contato mostra apenas se a pessoa estava disponível naquele minuto. Uma cadência mede interesse com contexto, timing e respeito.

Cadência principal: cinco toques em quatro dias

Toque	Momento sugerido	Função
1	No mesmo dia, conforme a operação	Facilitar a resposta e recuperar contexto.
2	Dia seguinte	Reduzir uma dúvida provável.
3	Segundo dia	Oferecer valor ou alternativa.
4	Terceiro dia	Criar decisão simples.
5	Quarto dia	Encerrar o ciclo com porta aberta.

ROTEIRO Toque 1 - Retomada simples

Situação: A pessoa não respondeu à pergunta anterior.

Objetivo: Trazer a conversa de volta sem acusar.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Voltei aqui porque quero te orientar sem deixar sua dúvida sobre [procedimento/avaliação] perdida na conversa.

O que faz mais sentido agora: eu te explicar [opção A] ou [opção B]?

Evite: "Viu minha mensagem?".

ROTEIRO Toque 2 - Redução de dúvida

Situação: Silêncio após apresentação da avaliação ou preço.

Objetivo: Antecipar uma barreira real.

MENSAGEM

Uma dúvida comum antes de marcar é não saber exatamente o que acontece na avaliação. Ela existe para [resumo concreto].

Se sua dúvida for outra, pode me dizer com tranquilidade que eu te respondo de forma objetiva.

ROTEIRO Toque 3 - Valor útil

Situação: A pessoa ainda não respondeu.

Objetivo: Entregar uma informação que ajude a decidir.

MENSAGEM

[Nome], deixo uma orientação importante: antes de comparar apenas valores, vale entender como cada profissional avalia a indicação, os limites e o acompanhamento.

Se quiser, eu te envio em duas linhas como organizamos isso aqui.

Evite: usar medo ou insinuar risco em outras clínicas.

ROTEIRO Toque 4 - Escolha simples

Situação: Existe interesse, mas nenhuma ação.

Objetivo: Criar resposta de baixo esforço.

MENSAGEM

Para eu não insistir no caminho errado: você prefere que eu **A)** veja horários, **B)** envie mais informações ou **C)** retome em outro momento?

Registrar: escolha A/B/C.

ROTEIRO Toque 5 - Encerramento respeitoso

Situação: Fim da cadência principal.

Objetivo: Preservar relacionamento e limpar o pipeline.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Vou encerrar meus retornos por agora para não ocupar seu WhatsApp.

Quando fizer sentido retomar [procedimento/avaliação], pode responder esta conversa e a equipe continua de onde parou.

Registrar: sem resposta - elegível para reativação futura.

Evite: culpa, ironia ou falsa escassez.

Follow-up por áudio

ROTEIRO DE 20 SEGUNDOS

"Oi, [Nome]. Passei só para não deixar sua dúvida sobre [tema] sem resposta. Não precisa decidir nada agora. Se você me disser o que ainda falta entender, eu consigo te orientar de forma bem mais objetiva."

PRINCÍPIO

Cada toque deve acrescentar algo: clareza, alternativa, contexto ou encerramento. Se apenas muda "oi" por "olá", não é cadência. É eco.

Confirmação e comparecimento

No-show raramente nasce no horário da consulta. Ele começa quando o compromisso ficou vago, distante ou cheio de pequenas dúvidas.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Sei exatamente o que vai acontecer e como me organizar.

Confirmar não é mandar "podemos confirmar?" várias vezes. É manter o compromisso vivo, remover fricção e facilitar remarcação antes que vire ausência.

Sequência de confirmação

Momento	Mensagem principal	Objetivo
No agendamento	Resumo completo.	Criar compromisso.
Com antecedência	Lembrete + orientações.	Facilitar planejamento.
Próximo da consulta	Pedido claro de confirmação.	Detectar risco de ausência.
No dia	Localização e acolhimento.	Reduzir atrito final.

ROTEIRO Lembrete antecipado

Situação: Consulta futura já agendada.

Objetivo: Reativar o compromisso e permitir organização.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Passando para lembrar você da sua avaliação com o Dr.(a) [Nome] em [data], às [hora].

O atendimento será em [local]. Se houver qualquer dificuldade com o horário, me avise para tentarmos organizar antes.

ROTEIRO Pedido de confirmação

Situação: Consulta próxima.

Objetivo: Obter resposta binária e liberar agenda quando necessário.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Sua avaliação está reservada para [data/hora]. Pode me confirmar sua presença até [prazo real]?

Se precisar remarcar, me avise por aqui para a equipe te ajudar.

Registrar: confirmado, pendente ou solicitou remarcação.

ROTEIRO No dia da consulta

Situação: Compromisso confirmado.

Objetivo: Facilitar chegada.

MENSAGEM

Bom dia, [Nome]. Estamos te esperando hoje às [hora]. A clínica fica em [endereço/referência].

Se tiver qualquer dificuldade no trajeto, pode falar com a gente por aqui.

Evite: enviar mensagem que pareça cobrança.

ROTEIRO Sem resposta à confirmação

Situação: A pessoa não confirmou dentro da política.

Objetivo: Buscar decisão e proteger agenda.

MENSAGEM

[Nome], ainda não recebemos sua confirmação para [data/hora]. Como a agenda precisa ser organizada, me responda, por favor, com:

- 1 - confirmo
- 2 - preciso remarcar
- 3 - prefiro cancelar

Registrar: resposta e horário do último contato.

NOTA DO OPERADOR

A melhor política de no-show é a que deixa consequências e caminhos claros antes do problema. Política escondida vira conflito; política explicada vira critério.

PROTEÇÃO DA AGENDA

- ☐ Resumo completo enviado no agendamento.
- ☐ Política de remarcação acessível.
- ☐ Lembrete enviado conforme cadência.
- ☐ Confirmação registrada.
- ☐ Endereço ou link enviados sem depender de pedido.

Cancelamento, atraso e no-show

A recuperação precisa proteger a agenda sem transformar um imprevisto em duelo.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Posso reorganizar com clareza e responsabilidade.

O objetivo não é punir. É distinguir imprevisto, desorganização recorrente e desinteresse, aplicando a política de forma consistente.

ROTEIRO Pedido de remarcação

Situação: A pessoa avisa com antecedência.

Objetivo: Acolher e oferecer nova decisão.

MENSAGEM

Obrigada por avisar, [Nome]. Vamos reorganizar.

Tenho [opção A] ou [opção B]. Alguma delas funciona para você?

Registrar: motivo administrativo, nova data e número de remarcações.

ROTEIRO Cancelamento sem nova data

Situação: A pessoa não quer ou não consegue remarcar agora.

Objetivo: Encerrar corretamente e combinar retomada.

MENSAGEM

Sem problema, [Nome]. Vou cancelar esse horário.

Você prefere que a equipe te procure novamente em [período] ou que deixemos a conversa aberta para quando fizer sentido?

Registrar: retomar em data X ou aguardando iniciativa.

ROTEIRO Atraso

Situação: Horário da consulta passou ou está próximo.

Objetivo: Entender a situação e orientar conforme a política.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Seu horário estava marcado para [hora] e ainda não conseguimos te localizar.

Você está a caminho? Me avise para eu verificar com a equipe como podemos organizar seu atendimento dentro da agenda de hoje.

Evite: garantir atendimento apesar do atraso.

ROTEIRO Primeiro no-show

Situação: A pessoa faltou sem avisar.

Objetivo: Checar bem-estar, registrar e oferecer rota conforme política.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Sentimos sua falta na avaliação de hoje e esperamos que esteja tudo bem.

Se aconteceu algum imprevisto, me avise. Posso te explicar como funciona a remarcação conforme a política da clínica.

Registrar: no-show, contato realizado e resposta.

ROTEIRO No-show recorrente

Situação: Segunda ausência ou repetição.

Objetivo: Aplicar critério sem agressividade.

MENSAGEM

[Nome], como já tivemos [número] horários reservados que não puderam ser utilizados, uma nova marcação estará sujeita à [política real: pagamento antecipado, lista de espera etc.].

Se estiver de acordo, eu te explico as próximas opções.

Evite: exceções improvisadas que tornam a política injusta.

NÃO FAÇA ISSO

Não use "perdemos tempo esperando você". A equipe pode ser firme sem transformar a falha do paciente em humilhação.

Tratamento de objeções

Objeção não é inimiga. É a forma que a dúvida encontrou para aparecer.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Minhas preocupações serão respondidas sem que tentem vencer uma discussão.

A estrutura é simples: reconhecer, investigar, responder, verificar e conduzir. Pular a investigação faz a equipe responder a uma objeção que a pessoa não tem.

A rota V-I-R-C

Passo	Pergunta interna	Exemplo
Validar	A pessoa se sentiu ouvida?	"Entendo por que isso importa para você."
Investigar	Qual é a dúvida por trás da frase?	"Quando você diz caro, está comparando com outra proposta ou com o momento financeiro?"
Responder	Entreguei uma explicação lógica e informações reais?	Explicação curta, prova autorizada e limite claro.
Conduzir	Existe um próximo passo proporcional?	"Quer avaliar horários ou prefere retomar em outro período?"

ROTEIRO "Vou pensar"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Identificar a dúvida real antes de encerrar.

MENSAGEM

Claro, [Nome]. Para eu não ficar insistindo sem necessidade: o que você ainda precisa entender para pensar com mais segurança: valores, recuperação em termos gerais, confiança no profissional ou organização de data?

ROTEIRO "Está caro"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Separar preço, capacidade de pagamento e comparação.

MENSAGEM

Entendo. Quando você diz que ficou caro, o peso maior está no valor da avaliação, no planejamento total ou no momento financeiro? Assim eu não te respondo de forma genérica.

ROTEIRO "Preciso falar com meu parceiro/minha família"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Dar suporte sem invadir a decisão.

MENSAGEM

Faz sentido alinhar uma decisão importante. Existe alguma informação que eu possa deixar clara para ajudar nessa conversa? Se preferir, combinamos de retomar em [dia].

ROTEIRO "Tenho medo"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Acolher e direcionar ao profissional.

MENSAGEM

Obrigada por falar isso. Medo antes de uma decisão cirúrgica merece ser tratado com seriedade, não empurrado para baixo do tapete.

O que preocupa mais você: anestesia, recuperação, resultado ou outra questão? A equipe pode organizar a avaliação para que o Dr.(a) [Nome] responda dentro do que for adequado.

ROTEIRO "Estou apenas pesquisando"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Transformar pesquisa em próximo passo leve.

MENSAGEM

Perfeito. Pesquisar com calma é uma forma responsável de decidir.

Para eu te ajudar sem pressionar, você prefere receber uma explicação curta sobre a avaliação ou deixar a conversa aberta para outro momento?

ROTEIRO "Vou consultar outros cirurgiões"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Não atacar comparação.

MENSAGEM

Faz sentido conversar com profissionais diferentes antes de decidir. Além de valores, observe se você consegue entender a indicação, os limites, a estrutura e o acompanhamento.

Quer que eu te explique como o Dr.(a) [Nome] organiza a avaliação para você comparar com mais clareza?

ROTEIRO "Não tenho tempo para recuperação"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Não definir prazo clínico.

MENSAGEM

Entendo. O impacto na rotina é uma parte importante da decisão. Como o tempo varia conforme o caso e o planejamento, a equipe não deve prometer isso por mensagem.

Na avaliação, você pode explicar sua rotina para o Dr.(a) [Nome] e entender o que seria considerado. Quer ver horários?

ROTEIRO "Moro longe"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Transformar distância em informação.

MENSAGEM

A distância realmente precisa entrar no planejamento. Podemos te explicar como a clínica organiza a avaliação e as etapas para quem vem de fora, sem prometer o que depende da análise médica.

Você quer entender primeiro a logística ou a disponibilidade?

ROTEIRO "Não sei se é o momento"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Distinguir pausa de dúvida.

MENSAGEM

Tudo bem não ter certeza agora. O que está pesando mais: prioridade pessoal, momento financeiro, medo ou falta de informação?

Dependendo da resposta, eu posso te orientar ou simplesmente combinar um momento melhor para retomar.

ROTEIRO "Quero resolver tudo pelo WhatsApp"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Definir limite sem parecer evasivo.

MENSAGEM

Eu consigo te orientar sobre processo, agenda e informações administrativas. O que exige avaliação individual precisa ser tratado com o Dr.(a) [Nome], porque seria irresponsável tirar conclusões por mensagem.

Posso organizar essa etapa para você.

ROTEIRO "Quero garantia de resultado"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Recusar promessa e oferecer clareza.

MENSAGEM

Entendo que você queira segurança. Nenhum atendimento responsável deve garantir um resultado individual antes de avaliar o caso.

O que a consulta pode oferecer é clareza sobre possibilidades, limites, planejamento e acompanhamento. Quer que eu explique como funciona?

ROTEIRO "Tive uma experiência ruim antes"

Situação: Objeção declarada durante a conversa.

Objetivo: Acolher sem criticar outro profissional.

MENSAGEM

Sinto muito que você tenha passado por isso. Obrigada por confiar essa informação.

Sem entrar em conclusões por mensagem, posso organizar uma avaliação para que você explique sua experiência e entenda como o Dr.(a) [Nome] conduz o processo.

Reativação

Uma conversa antiga não precisa voltar fingindo que o tempo não passou.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

A clínica se lembra do meu contexto e me dá liberdade para retomar ou não.

Reativar é oferecer uma nova porta de entrada com contexto. "Ainda tem interesse?" transfere todo o trabalho para a pessoa e revela que a clínica não lembra de nada.

Janelas de reativação

Janela	Quando usar	Ângulo
7-14 dias	Conversa recente sem decisão.	Retomar dúvida específica.
30 dias	Interesse real, timing ruim.	Mudança de disponibilidade ou novo contexto.
60-90 dias	Pesquisa longa ou organização financeira.	Reabrir sem assumir prioridade.
6 meses+	Projeto adiado.	Confirmar se ainda faz sentido manter contato.

ROTEIRO Reativação de 7 a 14 dias

Situação: A pessoa parou após uma dúvida específica.

Objetivo: Retomar do ponto exato.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Quando conversamos, sua principal dúvida era [dúvida]. Conseguiu esclarecer ou isso ainda está impedindo você de avançar para a avaliação?

Registrar: resposta e novo motivo de perda.

ROTEIRO Reativação de 30 dias

Situação: Ela pediu tempo ou não tinha agenda.

Objetivo: Reconhecer o combinado.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Combinamos de retomar neste período porque [contexto real]. Ainda faz sentido conversar sobre [procedimento/avaliação] ou prefere que eu encerre os retornos?

Evite: fingir intimidade ou urgência.

ROTEIRO Reativação com disponibilidade real

Situação: A agenda abriu uma opção relevante.

Objetivo: Apresentar oportunidade sem falsa escassez.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Surgiu disponibilidade para avaliação em [data/período], e lembrei que você estava tentando organizar [contexto].

Quer que eu verifique as opções ou esse momento ainda não funciona?

Evite: "última vaga" se não for verdade.

ROTEIRO Reativação longa

Situação: Mais de seis meses sem conversa.

Objetivo: Pedir permissão para manter o relacionamento.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Faz algum tempo que conversamos sobre [procedimento]. Antes de manter qualquer retorno, queria confirmar: esse planejamento ainda faz sentido para você ou prefere que a clínica não entre mais em contato sobre ele?

Registrar: manter, pausar ou remover da reativação.

ROTEIRO Reativação após avaliação

Situação: A pessoa foi avaliada e adiou a decisão.

Objetivo: Retomar com respeito ao contexto médico e pessoal.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Estou retomando o contato, conforme combinamos após sua avaliação com o Dr.(a) [Nome].

Você conseguiu organizar as dúvidas e o momento, ou existe alguma informação administrativa em que a equipe possa ajudar?

Evite: reabrir decisão médica sem contexto do prontuário ou orientação adequada.

NOTA DO OPERADOR

Reativação precisa de memória. Sem registro de contexto, a clínica parece uma central de disparos tentando ressuscitar nomes em uma planilha.

Pós-avaliação e decisão

Depois da consulta, a pessoa pode ter informação suficiente e ainda não ter clareza emocional ou operacional.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Posso decidir no meu ritmo sem perder acesso à informação e à organização.

O pós-avaliação não deve transformar orientação médica em campanha de pressão. Ele existe para confirmar entendimento, resolver pendências administrativas e organizar o próximo passo escolhido pela pessoa.

ROTEIRO Mensagem após a avaliação

Situação: Consulta realizada.

Objetivo: Agradecer e abrir canal para dúvidas administrativas.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Obrigada por comparecer à avaliação hoje. Espero que a conversa tenha ajudado a esclarecer suas possibilidades.

Se surgir alguma dúvida administrativa sobre datas, documentos, valores ou próximos passos, pode falar comigo por aqui.

Evite: perguntar imediatamente "vamos fechar?".

ROTEIRO Follow-up combinado

Situação: A pessoa pediu dias para pensar.

Objetivo: Retomar no prazo acordado.

MENSAGEM

Oi, [Nome]. Na avaliação, combinamos de retomar hoje. Como você se sente em relação ao planejamento apresentado?

Existe alguma dúvida que ainda precisa ser esclarecida com a equipe ou com o Dr.(a) [Nome] pelo canal adequado?

Registrar: dúvida, status e próxima ação.

ROTEIRO Organização de datas

Situação: A pessoa quer avançar, mas precisa de agenda.

Objetivo: Transformar desejo em janela concreta.

MENSAGEM

Perfeito. Para eu verificar possibilidades com a equipe, quais períodos seriam viáveis para você e quais são impossíveis?

Depois confirmamos o que depende da agenda e das orientações do planejamento.

Evite: prometer data antes de validar toda a operação.

ROTEIRO Organização financeira

Situação: A barreira é a forma de pagamento ou o momento financeiro.

Objetivo: Entregar opções reais sem pressionar.

MENSAGEM

Entendi. Posso te apresentar as formas de pagamento e condições reais da clínica para você avaliar com calma.

Você prefere receber um resumo por escrito ou conversar rapidamente por aqui?

Evite: criar endividamento como argumento ou minimizar impacto financeiro.

ROTEIRO Pessoa escolheu outro profissional

Situação: Ela comunica a decisão.

Objetivo: Encerrar com respeito e aprender quando apropriado.

MENSAGEM

Obrigada por nos avisar, [Nome]. Esperamos que seu processo seja seguro e tranquilo.

Se você se sentir confortável em responder, existe algo no nosso atendimento que poderíamos ter explicado ou organizado melhor? Sua resposta ajuda a equipe a melhorar.

Registrar: motivo declarado, sem discutir a escolha.

ROTEIRO Pessoa decidiu não realizar

Situação: Ela encerrou o projeto.

Objetivo: Respeitar a decisão e encerrar contato.

MENSAGEM

Entendido, [Nome]. Obrigada pela transparência. Vou registrar para que a equipe não continue entrando em contato sobre esse planejamento.

Se um dia você quiser retomar, estaremos por aqui.

O fechamento responsável

Fechamento ruim	Fechamento responsável
Cria medo de perder a chance.	Explica condições e prazos verdadeiros.
Insiste depois de um não claro.	Registra a decisão e encerra.
Promete resultado.	Reforça limites e planejamento individual.
Força pagamento antes da clareza.	Organiza informação e escolha.
Usa depoimento como garantia.	Usa prova apenas como contexto, com autorização.

PRINCÍPIO

A melhor venda é aquela em que a pessoa entende o que está escolhendo. Pressão pode antecipar um pagamento e atrasar um problema.

PARTE IV

Gestão, treinamento e escala

O que não é registrado vira opinião. O que não é
revisado vira hábito.

CEVORA

Medição e melhoria

O livro mostra o que responder. A gestão mostra se a equipe respondeu, acompanhou e converteu.

CRENÇA QUE PRECISA EXISTIR

Esta clínica aprende com cada conversa em vez de repetir o mesmo vazamento.

Sem dados, "o paciente sumiu" encerra qualquer investigação. Com dados, a clínica descobre se perdeu por demora, preço, falta de follow-up, agenda, concorrência, medo, no-show ou ausência de próximo passo.

Indicadores essenciais

Indicador	Fórmula operacional	Pergunta que responde
Tempo de primeira resposta	Hora da resposta - hora da entrada.	Estamos deixando interesse esfriar?
Continuidade	Conversas com segunda interação / novos contatos.	Nossa primeira resposta convida a pessoa a continuar a conversa?
Avaliação apresentada	Pessoas que receberam explicação / qualificadas.	A equipe chega ao próximo passo?
Agendamento	Avaliações agendadas / pessoas qualificadas.	A condução vira compromisso?
Confirmação	Confirmadas / agendadas.	A agenda está protegida?
Comparecimento	Comparecimentos / avaliações agendadas.	Onde o no-show nasce?
Follow-up executado	Ações feitas / ações previstas.	O processo depende da memória?

Indicador	Fórmula operacional	Pergunta que responde
Motivo de perda conhecido	Perdas categorizadas / perdas totais.	Aprendemos com o não?

Dicionário de motivos de perda

Categoria	Definição
Sem resposta	Não respondeu após a cadência completa.
Preço da avaliação	Recusou especificamente o investimento da consulta.
Planejamento financeiro	Interesse existe, mas o momento não permite.
Escolheu outro profissional	Decisão comunicada.
Agenda	Não encontrou horário ou período viável.
Distância	Logística inviabilizou o próximo passo.
Medo/insegurança	Barreira declarada e não resolvida.
Não compareceu	Agendou e faltou.
Sem indicação/decisão médica	Encerramento clínico, quando registrado no canal adequado.
Desistiu/adiou	Decisão pessoal explícita.
Atendimento	Reclamação ou evidência de falha da própria operação.

NOTA DO OPERADOR

"Sumiu" não é causa. É ausência de investigação. A categoria correta não serve para culpar a pessoa; serve para descobrir qual parte da máquina precisa ser corrigida.

Auditoria de conversa: 20 pontos

Critério	0 pontos	1 ponto	2 pontos
Personalização	Genérica.	Nome apenas.	Contexto real usado.
Clareza	Confusa.	Compreensível.	Curta e precisa.

Critério	0 pontos	1 ponto	2 pontos
Acolhimento	Fria/julgadora.	Educada.	Valida sem exagero.
Condução	Sem próximo passo.	Pergunta vaga.	Escolha clara.
Limite clínico	Invade ou promete.	Limite parcial.	Encaminha corretamente.
Preço	Esconde ou solta um número.	Responde incompleto.	Valida, responde e contextualiza.
Follow-up	Não feito.	Feito fora do prazo.	Cadência executada.
Registro	Nada.	Status apenas.	Contexto + próxima ação.
Tom	Agressivo/robótico.	Neutro.	Profissional e humano.
Encerramento	Pressiona ou abandona.	Encerra.	Encerra e preserva retorno.

Ritual semanal de 30 minutos

1. Escolha cinco conversas por atendente: duas convertidas, duas perdidas e uma em andamento.
2. Pontue sem discutir a intenção. Avalie o que está escrito e registrado.
3. Identifique um único padrão de falha da semana.
4. Reescreva ou ajuste um script, uma política ou uma etapa.
5. Defina um indicador para verificar se a mudança funcionou.
6. Revise na semana seguinte antes de abrir outro projeto.

Treinamento por simulação

Papel	Instrução
Paciente	Escolha uma objeção, esconda parte da preocupação e responda naturalmente.
Atendente	Conduza sem diagnosticar, pressionar ou ler como robô.
Observador	Marque clareza, próximo passo, limite e registro.
Gestor	Corrija o mecanismo, não a personalidade.

PONTE PARA TECNOLOGIA

Este manual pode ser aplicado com etiquetas, planilha e disciplina. O próximo gargalo aparece quando a clínica precisa saber, em tempo real, quem fez follow-up, onde cada conversa parou e qual atendente converte melhor.

O material mostra o caminho. O software acende os faróis.

OPERAÇÃO MENSURÁVEL

- ☐ Pipeline com etapas definidas.
- ☐ Responsável por cada conversa.
- ☐ Próxima ação e prazo registrados.
- ☐ Motivos de perda padronizados.
- ☐ Auditoria semanal executada.
- ☐ Mudanças comparadas por indicador.

APÊNDICES

Biblioteca de uso rápido

Abra na situação, adapte o contexto e conduza.

CEVORA

Índice por situação

Quando a conversa está acontecendo, você não precisa lembrar o nome do módulo. Precisa encontrar o problema.

Situação	Ir para
Mandou apenas "oi"	Módulo 3 - Primeiro contato
Perguntou valor	Módulo 7 - Pergunta de preço
Quer saber quem é o cirurgião	Módulo 5 - Apresentação
Não sabe qual procedimento	Módulo 4 - Qualificação
Mora em outra cidade	Módulos 4 e 13
Quer falar direto com o médico	Módulo 8 - Avaliação
Aceitou agendar	Módulo 9 - Agendamento
Parou de responder	Módulo 10 - Follow-up
Não confirmou	Módulo 11 - Confirmação
Faltou	Módulo 12 - No-show
Disse "vou pensar"	Módulo 13 - Objeções
Pediu para retomar depois	Módulo 14 - Reativação
Foi avaliada(o), mas não decidiu	Módulo 15 - Pós-avaliação
Gestor não sabe onde perde	Módulo 16 - Medição

Banco de mensagens para copiar e adaptar

Use como ponto de partida. Colchetes vazios e contexto ignorado são o uniforme oficial do atendimento robótico.

Primeiro contato

Oi, [Nome]. Vi que você quer saber mais sobre [procedimento]. O que você gostaria de esclarecer primeiro: avaliação, disponibilidade ou outra dúvida específica?

Pergunta de preço

Entendo que o investimento importa. Como o valor depende do planejamento individual, eu não consigo te passar um valor total com responsabilidade antes da avaliação. Posso te explicar o valor da consulta e os próximos horários?

Apresentação da avaliação

A avaliação é o momento em que o Dr.(a) [Nome] entende seu objetivo, analisa seu caso e explica possibilidades, limites e planejamento. Quer que eu veja disponibilidade?

Escolha de horário

Tenho [opção A] ou [opção B]. Qual funciona melhor para você?

Retomada

Oi, [Nome]. Voltei porque quero te orientar sem deixar sua dúvida sobre [tema] perdida. Faz mais sentido eu explicar [A] ou [B]?

Confirmação

Sua avaliação está reservada para [data/hora]. Pode me confirmar sua presença até [prazo]? Se precisar remarcar, me avise por aqui.

No-show

Sentimos sua falta hoje e esperamos que esteja tudo bem. Se aconteceu algum imprevisto, me avise e eu te explico como funciona a remarcação.

Vou pensar

Claro. O que você ainda precisa entender para pensar com mais segurança: valores, processo, confiança ou organização de data?

Reativação

Quando conversamos, sua principal dúvida era [dúvida]. Isso ainda está impedindo você de avançar ou seu momento mudou?

Encerramento

Vou encerrar meus retornos por agora para não ocupar seu WhatsApp. Quando fizer sentido retomar, pode responder esta conversa.

Modelos operacionais

Ficha mínima de conversa

Campo	Preenchimento
Nome	
Canal/origem	
Procedimento de interesse	
Dúvida principal	
Cidade	
Etapa atual	
Última ação	
Próxima ação + prazo	
Responsável	
Motivo de perda, se houver	

Checklist diário da atendente

FECHAMENTO DO TURNO

- ☐ Novos contatos respondidos.
- ☐ Conversas sem próximo passo identificadas.
- ☐ Follow-ups do dia executados.
- ☐ Consultas próximas confirmadas.
- ☐ Remarcações e cancelamentos atualizados.
- ☐ Motivos de perda registrados.
- ☐ Conversas sensíveis encaminhadas ao responsável adequado.

Quadro de reunião semanal

Pergunta	Resposta da semana
Onde mais pacientes pararam?	
Qual objeção apareceu com mais frequência?	
Qual script teve melhor continuidade?	
Qual etapa dependeu da memória?	
Qual única mudança será testada?	
Qual indicador confirmará o resultado?	

Implantação em sete dias

Não tente treinar com mensagens de uma vez. Instale a espinha dorsal, observe e refine.

Dia	Entrega	Ação prática
1	Mapa atual	Reúna 30 conversas recentes e marque onde pararam.
2	Pipeline	Defina etapas, responsáveis e critérios de avanço.
3	Primeiro contato	Escolha duas versões e simule dez conversas.
4	Preço + avaliação	Padronize o que pode ser informado e o que depende da consulta.
5	Agendamento + confirmação	Crie resumo, política e sequência.
6	Follow-up + objeções	Configure a cadência e treine V-I-R-C.
7	Medição	Defina a linha de base, a auditoria e a mudança da semana.

Meta da primeira semana

não é VENDER MAIS A QUALQUER CUSTO

A meta é retirar o imprevisto suficiente para que a clínica consiga observar o processo. O ganho de conversão deve surgir de mais clareza, melhor acompanhamento e menos oportunidades esquecidas.

Gerador de variações sem perder a VOZ

Uma IA pode variar palavras. A equipe ainda precisa fornecer contexto, limite e objetivo.

PROMPT-BASE

Você é um redator de atendimento para uma clínica de cirurgia plástica. Escreva uma mensagem curta, humana e profissional.

Etapa: [etapa]

Contexto real da pessoa: [contexto]

Objetivo único: [objetivo]

Informações que podem ser afirmadas: [informações verificadas]

O que não pode ser prometido: diagnóstico, indicação, resultado, prazo clínico ou urgência falsa.

Tom: [objetivo/acolhedor].

Saída: duas versões de até quatro linhas, terminando com pergunta ou escolha simples.

Teste de consistência da persona

O FILHO DA CLÍNICA

- ☐ A mensagem ataca um problema, não uma pessoa.
- ☐ Existe uma explicação de mecanismo, não apenas frase bonita.
- ☐ O tom é direto sem ser agressivo.
- ☐ A equipe se coloca ao lado da operação, não acima do médico.
- ☐ Não existe número, prova ou promessa inventada.
- ☐ O próximo passo é prático e mensurável.

Referências de método

Este manual é uma obra original da Cevora. Sua arquitetura foi desenvolvida a partir da operação proposta pela marca e de uma síntese crítica das seguintes referências de estudo:

- **Victor O. Schwab.** *How to Write a Good Advertisement*. Fundamentos de atenção, vantagem, prova, compreensão e ação.
- **Evaldo Albuquerque.** *The 16-Word Sales Letter*. Crença central, mecanismo e sequência de perguntas para organizar persuasão.
- **Dan S. Kennedy.** *The Ultimate Sales Letter*. Pesquisa do cliente, oferta, objeções, clareza de preço, urgência legítima e sequências.
- **The Perfect Video Sales Letter.** Estrutura de introdução, problema, consequência, solução, benefícios, prova, oferta e chamada para ação.
- **Playbook de Social Selling Cevora.** Personalização, microcompromissos, investigação progressiva e fechamento por escolhas específicas.
- **Manual de Persona Cevora - O Filho da Clínica.** Voz, história, posicionamento, polaridade e governança editorial.

Os conceitos foram adaptados para um contexto de atendimento em saúde que exige prudência, transparência, respeito à decisão da pessoa e separação rigorosa entre orientação comercial e critério médico.



CEVORA

Competência clínica não se distribui sozinha.

Agora a equipe tem o caminho: acolher, compreender,
apresentar, acompanhar, registrar e melhorar.



O material mostra o caminho.
O software acende os faróis.